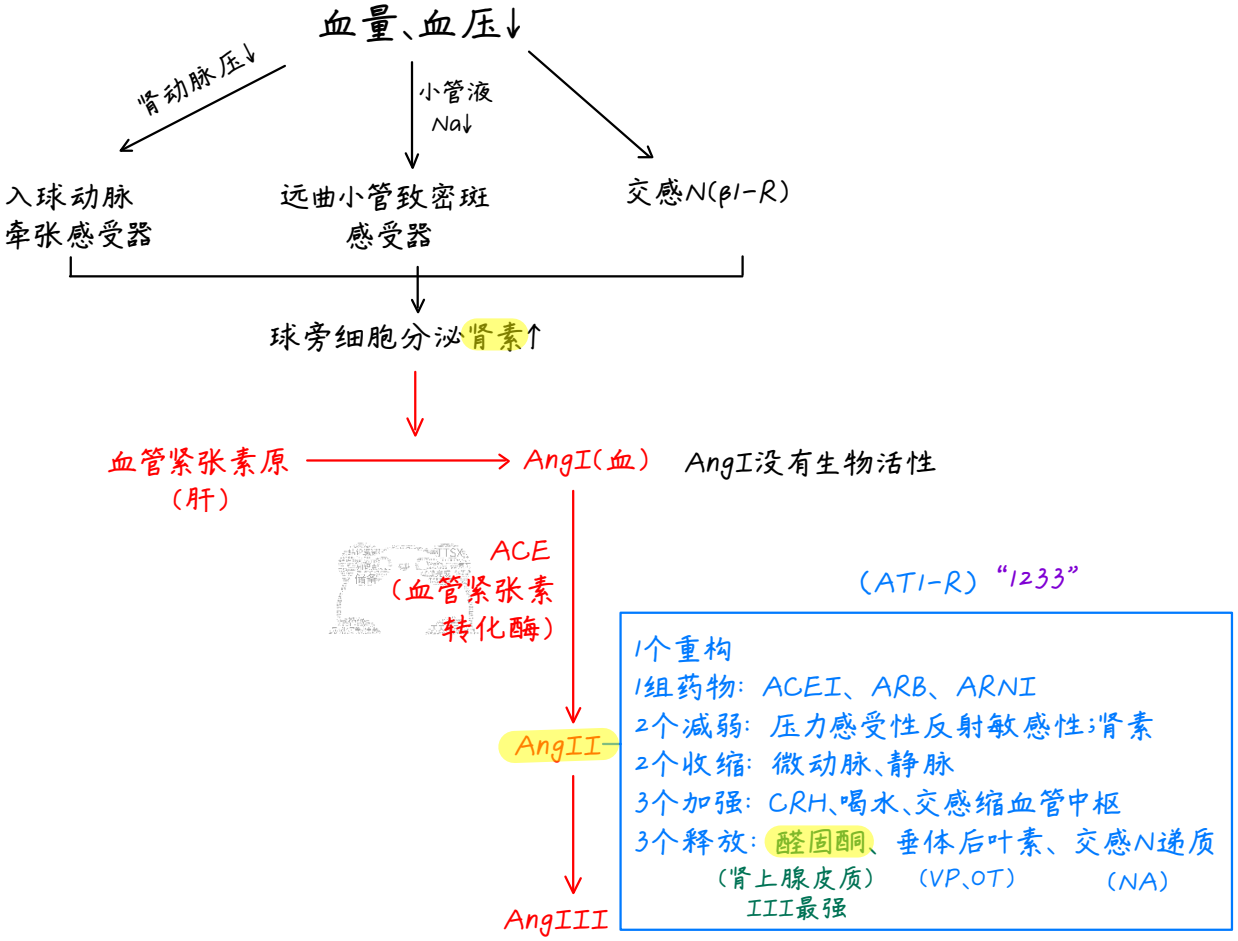
2.血管紧张素（用升血压效应去理顺，记忆时注意箭头几乎为↑）



阻力血管"小薇"　舒↑↑、缩↑、平均动脉压↑

全身微动脉收缩（外周阻力↑） **静脉收缩**（回心血量↑）≫前负荷↑→搏出量↑(F-S机制)→缩↑↑、舒↑、平均动脉压↑	AngII**最强**
促肾上腺皮质激素释放激素 CRH 作用 ↑→ACTH↑→GC↑允许作用(增加儿茶酚胺作用的受体)	糖皮质激素有允许作用 GC自身不能升血压,却是儿茶酚胺能够发挥缩血管效应的关键,没有GC儿茶酚胺对心血管不敏感
直接促进 肾上腺**皮**质球状带分泌**醛固酮**↑	Ang**III最强**三全凌汤圆　失血>30%:输1/2全血+1/2浓缩红 醛固酮亲爹 RAAS、糖皮质激素亲爹是 ACTH
垂体后叶素（血管升压素 VP/ADH 和缩宫素/催产素 OT）↑ ADH 抗利尿、大剂量还可收缩血管	下丘脑→储存在神经垂体（垂体后叶） 串：垂体后叶素是内科医生的止血钳；垂体后叶素禁用高血压、冠心病(收缩冠脉)、心衰(后负荷增加)、孕妇(收缩胎盘血管)
引起**口渴**和喝水	AngII刺激下丘脑室周器**穹窿下器→ADH↑**
调节**交感神经**活动度 （交感和 RAAS 是好基友）	交感神经释放**递质 NA/NE↑** 交感缩血管中枢紧张性↑
中枢对压力感受性反射的**敏感性↓**	参与高血压重调定
肾素↓ EVA	负反馈 ttsx
促进心血管**重构** 心肌C实质不可增生,间质可以增生	重构指心肌细胞肥大和凋亡、心肌成纤维细胞和血管增殖、细胞外基质堆积（纤维化） **AngII和醛固酮是心血管重构的主要原因**